Introduzione al Lavoro sociale

Le finalità del lavoro sociale

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Promuovere:

- ***qualità di vita*** e ***salute***
- ***benessere psichico, fisico, sociale e spirituale***
- ***l'empowerment***
- ***l'autonomia, l'autodeterminazione, l'autoefficacia, l'autostima e la creatività***
- **processi di *integrazione*, *inclusione* e *partecipazione* sociale**
- sviluppo della ***giustizia sociale*, del *rispetto dell'ambiente* e dei *contesti di vita***

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Il modello della qualità di vita (qdv)

Definizione

Il concetto di Qualità di Vita (QdV) è ambito di interesse e di studio in diverse discipline. Ciascuna ha sviluppato una differente prospettiva in merito alla sua concettualizzazione ed applicazione (Bergland & Narum, 2007). **In letteratura sono presenti molte definizioni.** Ad esempio, **il gruppo di lavoro sulla QdV dell'OMS** l'ha definita nel 1995 come: ***«La percezione dell'individuo della propria posizione nella vita nel contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento nei quali è inserito e in relazione ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi»*** (WHOQOL, The World healt organization quality of life assessment, 1995). Renwick e Brown parlano del «grado in cui una persona usufruisce a pieno delle possibilità/opportunità importanti della sua vita.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Il modello della qualità di vita (qdv)

Gli 8 domini della QdV

Il paradigma della Qualità di Vita ha un carattere universale perché si applica ad ogni essere umano, ma anche personale poiché si declina in ogni storia di vita varia in funzione della percezione che ognuno/a di noi ha del suo stare -bene- nel mondo.

Oggier-Fusi, D.,(2023). *Io sogno, io scelgo*. Dossier atgabbes.

- Shalock, Verdugo, 2006, Manuale della qualità di vita, Vannini, Brescia, p.60 schematizzazione a cura del team del modulo TMIS 2020/2021

Il modello della qualità di vita (qdv)

- L'interconnessione tra i diversi domini della QdV è inevitabile e ciò comporta che essi si influenzino reciprocamente.
- La QdV di una persona non può essere spiegata, considerata o misurata mediante una visione approssimativa di una sola dimensione.
- Occorre assumere la consapevolezza che ogni nuovo elemento che si inserisce nella vita della persona ha effetti, non solo sulla dimensione che si vuole potenziare, ma anche sulle altre in modo trasversale.

- Carbonari, M. (2017). Leggere la qualità di vita dell'adulto con disabilità. Tesi di dottorato, Università di Macerata, p.20

Il modello della qualità di vita (qdv)

I 7 principi di funzionamento del paradigma della QdV:

Multidimensionalità
Superamento degli approcci unidimensionali

Visione olistica
Interconnessione e influenza reciproca dei vari aspetti considerati

Elementi soggettivi ed elementi oggettivi (unicità)
Necessità di considerare sia variabili socio-culturali sia la narrazione di senso del soggetto

Estendibilità a tutte le persone
Rilevanza del modello per tutte le persone, non solo per le persone con disabilità

Variabilità personale
Diversa significatività che la persona attribuisce ai singoli domini

Temporalità
Prospettiva longitudinale: i valori attribuiti dalla persona variano nel tempo

Empowerment
Aspetti particolarmente legati all'emancipazione della persona

Carbonari, M. (2017). Leggere la qualità di vita dell'adulto con disabilità. Tesi di dottorato, università di Macerata, p. 19 -24.
Schematizzazione a cura del modulo TMIS 2020-2021

Il modello della qualità di vita (qdv)

AREE TRASVERSALI	DOMINI	INDICATORI
Indipendenza	Sviluppo personale	Livello di educazione, abilità personali, comportamento adattivo
	Autodeterminazione	Scelte/decisioni, autonomia, controllo personale, obiettivi personali
Partecipazione sociale	Relazioni interpersonali	Rete sociale, amicizia, attività sociali, relazioni
	Inclusione sociale	Integrazione/partecipazione nella comunità, ruoli nella comunità
	Diritti	Umani (rispetto, dignità, uguaglianza), legali (assistenza legali, doveri di cittadino)
Benessere	Benessere emozionale	Salute e sicurezza, esperienze positive, concetto di sé,
	Benessere fisico	Stato di salute, stato nutrizionale, esercizio fisico e ricreativo
	Benessere materiale	Status finanziari, stato lavorativo, stato abitativo

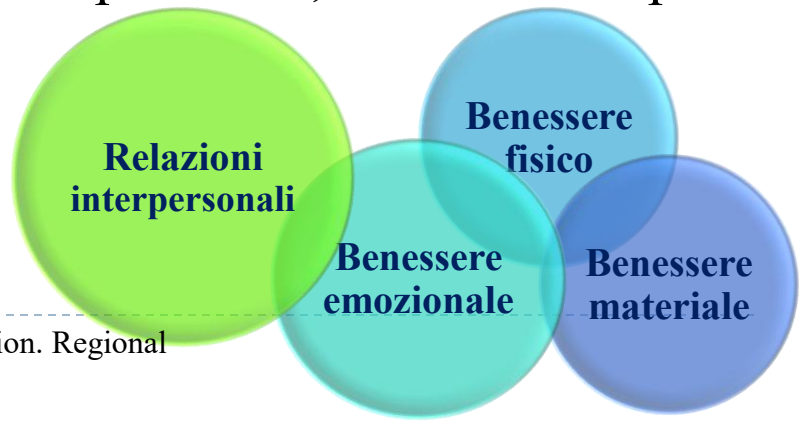
Shalock e Verdugo Alonso, 2008 – riadattamento di Lombardi, 2013 (tratta da «Progettare qualità della vita. Report conclusivo e risultati progetto di ricerca. Strumenti verso l'inclusione sociale – matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o evolutive» Anffas Onlus, 2015)

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

SALUTE

La Costituzione dell'OMS del 1948 ha definito la salute come:

Uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale e non soltanto l'assenza di malattia o di infermità. In promozione della salute, la salute viene considerata non tanto una condizione astratta, quanto un mezzo finalizzato ad un obiettivo che, in termini operativi, si può considerare una risorsa che permette alle persone di condurre una vita produttiva sul piano individuale, sociale ed economico. La salute è una risorsa per la vita quotidiana e non lo scopo dell'esistenza. Si tratta di un concetto positivo che valorizza le risorse sociali e personali, oltre alle capacità fisiche.



World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Regional Office for Europe.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

SALUTE

Partendo dall'assunto che **la salute è un diritto umano fondamentale**, la Carta di Ottawa mette in evidenza alcuni pre-requisiti necessari: la pace, risorse economiche adeguate, il cibo e l'abitazione, un eco-sistema stabile ed un uso sostenibile delle risorse.

Il riconoscimento di questi pre-requisiti sottolinea una **visione olistica** della salute in cui vengono considerati i complessi legami esistenti tra le condizioni sociali ed economiche, l'ambiente fisico, gli stili di vita individuali e la salute. Oggi viene riconosciuta sempre di più la dimensione spirituale della salute.

Una comprensione globale della salute implica che tutti i sistemi e le strutture deputate a governare le condizioni socio-economiche e l'ambiente fisico, debbano agire considerando l'impatto che il loro operato avrà sulla salute e sul benessere dei singoli individui e dell'intera comunità.

World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Regional Office for Europe.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

SALUTE

Salute_Consiglio d'Europa

Benessere materiale

"Tra le libertà più importanti che abbiamo c'è la libertà dalle malattie curabili e dalla mortalità evitabile."
Amartya Sen

Diritti

Benessere emozionale

Approfondimento mirato alla Confederazione Svizzera:
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/temi/salute-e-promozione-della-salute.html

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

E MALATTIA

Concetto triadico dello stato di malattia di A. Twaddle:

- **Disease** è la malattia fisica vera e propria che colpisce il malato e riguarda tutti i sintomi e i segni che il medico può constatare e tramite i quali può fare la diagnosi occupandosi del reale stato di salute del soggetto.
- **Illness** è la sensazione che il soggetto ha del proprio star male, una percezione personale che lo porta a entrare in contatto con i suoi pensieri e sentimenti. Parliamo di una visione soggettiva del sentirsi, mediata anche dal background culturale.
- **Sickness** è il modo in cui il contesto sociale e culturale interpretano la malattia dell'individuo, [il] che implica di conseguenza certi diritti e certi obblighi derivanti dal riconoscimento sociale della patologia.

Tali dimensioni del concetto salute-malattia sono interconnesse e possono essere variabilmente presenti in un individuo in un dato momento. La malattia biologica, il malessere psicologico e l'adattamento sociale trovano una gestione specifica e differente in ogni singolo soggetto e nelle diverse popolazioni. **È l'esperienza umana a creare la malattia in tutti i suoi aspetti**.

- Da Caiozzo M. S., Merlino G. (2014). *Disease, illness e sickness: malati o malattie? Studio sulla QDV-S in 60 outpatients.* in Rivista Società Italiana di Medicina Generale, n. 6.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Benessere collettivo

Sensazione positiva collettiva determinata dalla percezione di sentirsi riconosciuti come collettività, di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita sociale, poter usufruire di beni, servizi e di condividere una solidarietà sociale.

Dal Pra Ponticelli, M. (2007). *Dizionario di servizio sociale.* Carocci, pp. 74 - 77

Autodeter minazione

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Benessere individuale– Modello PERMA di Martin E. P. Seligman

Promozione del flourishing = funzionamento ottimale: stare bene e funzionare efficacemente

Emozioni positive: atteggiamento mentale positivo. Guardare al passato con orgoglio, nel futuro con speranza.

Coinvolgimento: essere completamente presente in quello che si sta facendo e negli obiettivi da raggiungere. Concentrarsi su cose che ci interessano e ci piacciono (*Flow*).

Relazioni sociali: costruire relazioni sociali forti e positive con le persone intorno a noi, i familiari, amici, colleghi, vicini. Impatto positivo sulla salute e in caso di difficoltà.

Significato: fa riferimento ad una sfera quasi spirituale in Seligman. Sapere e sentire che la nostra vita ha un senso. Credere in qualcosa di grande o avere una missione nella vita (Dio, comunità…).

Realizzazione: è la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo nella propria vita. Essa alimenta pensieri positivi e autostima e permette di guardare al futuro con ottimismo, slancio e nuova carica (principio di auto efficacia).

Sviluppo personale

Benessere emozionale

Laudadio, A., Mancuso, S. (2015). *Manuale di Psicologia positiva.* Franco Angeli, p.117-122.

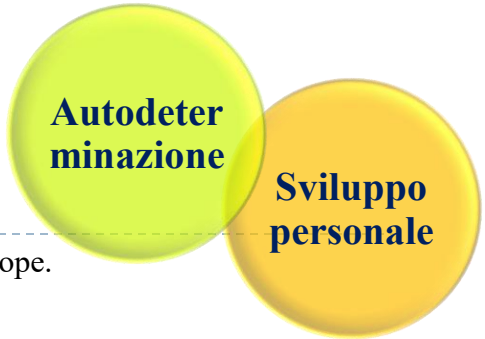
Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Empowerment (def. OMS)

L'empowerment è un processo sociale, culturale, psicologico o politico attraverso il quale gli individui e i gruppi sociali sono in grado di esprimere i propri bisogni e le proprie preoccupazioni, individuare le strategie per essere coinvolti nel processo decisionale e intraprendere azioni di carattere politico, sociale e culturale che consentano loro di soddisfare tali bisogni. Attraverso questo processo gli individui riescono a percepire una più stretta corrispondenza tra i propri obiettivi di vita e il modo in cui raggiungerli, ma anche una correlazione tra gli sforzi compiuti e i risultati ottenuti.

Viene fatta una distinzione tra:

- *empowerment degli individui* - si riferisce soprattutto alla capacità del singolo individuo di prendere decisioni e di assumere il controllo della propria vita
- *empowerment di comunità*- si riferisce agli individui che agiscono a livello collettivo per riuscire a influenzare e controllare maggiormente i determinanti di salute e la qualità della vita nella propria comunità.



World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Regional Office for Europe.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Empowerment relazionale

Nell'approccio postmoderno al lavoro sociale, in considerazione della complessità dei sistemi, si tende ad integrare le diverse visioni precedenti. Nasce così il concetto di *empowerment relazionale*, legato strettamente al lavoro di rete inteso come processo collaborativo di apprendimento reciproco volto alla valorizzazione delle potenzialità degli individui e delle collettività, per accrescerne la possibilità di autodeterminazione nell'organizzazione della propria vita.

In un processo di questo tipo, le persone coinvolte nella relazione di aiuto (esperti, utenti, familiari e cittadini), ricercano e sviluppano risorse e competenze individuali o collettive per trovare risposte efficaci ai propri bisogni. Gli esperti «cedono» parte del loro potere di trovare soluzioni alle persone con cui lavorano restituendo dignità e valore e acquisendo un ruolo di orientamento, accompagnamento e sostegno, più che di sostituzione direttiva.

- Folgheraiter, F. (a cura di). (2004). *Il servizio sociale postmoderno: modelli emergenti.* Erickson, pp.37-49

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Autonomia

La condizione di chi ha la **capacità di organizzare le proprie azioni, scelte, comportamenti**, tenendo conto di se stessi e dei fattori che entrano in gioco nel proprio ambito esperienziale, nella complessa rete di **dipendenze funzionali** che lega il soggetto agli altri.

Più che una caratteristica acquisita una volta per tutte, l'autonomia rappresenta piuttosto una delle **mete del processo educativo** che a seconda delle età e dei **contesti di vita** dell'individuo assume forme e caratteristiche diverse.

Può essere talvolta necessario limitare l'autonomia altrui?

Tramma, S. (2018). *L'educatore imperfetto. Terza edizione.* Carocci, pp. 80-83.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Autonomia

- Non si può mai ritenere un soggetto completamente autonomo in senso astratto; altra cosa è pensare l'autonomia come un approccio che permette di «farsi opera di se stessi» entro le proprie condizioni di vita.
- La **sfera di autonomia** va riportata alle specificità del contesto e degli obiettivi (educativi, sociali, sanitari, di insegnamento…).
- Il **livello di autonomia** deve essere definito a partire dal livello già raggiunto dalla persona: deve rappresentare un livello superiore e tuttavia *accessibile*.
- Meirieu propone in questo senso di parlare di «processo di autonomizzazione».
- L'operatore sociale deve, pertanto, «sforzarsi di rendere il soggetto autonomo. Non supporlo già autonomo, ma organizzare un sistema di aiuti che gli permetta di raggiungere gli obiettivi che si fissa, prima di portarlo a fare progressivamente a meno di questi aiuti e ad applicare per conto suo, di sua iniziativa e in altre situazioni quello che ha acquisito» (p. 90).

Meirieu, P. (2007). *Frankenstein educatore.* Junior, pp. 87-91.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Autostima

Etimologicamente la parola autostima deriva dal verbo latino *«aestimare»,* che significa sia «**determinare il valore di**» sia «**avere un'opinione su**». La stima di sé rappresenta quindi generalmente il modo in cui **ciascuno vede e valuta se stesso**.

L'attribuzione di valore (esplicita o implicita) che l'individuo si conferisce ed è in gran parte determinata da:

- le **aspettative** dell'individuo su sé stesso
- la raggiungibilità o meno dei **modelli di riferimento**
- la **qualità delle relazioni** sperimentata
- i **feedback ricevuti** in ambito sociale, lavorativo e affettivo

Bandura, A. (2012). *Autoefficacia. Teorie e applicazioni.* Erickson, pp.33-36.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Autoefficacia

Le **convinzioni** circa le proprie capacità di organizzare ed eseguire le sequenze di azioni necessarie per produrre determinati risultati. Si riferisce alla **percezione di sé** come capace di ottenere un dato effetto e di raggiungere uno scopo, di essere all'altezza di determinati eventi.

Le convinzioni di autoefficacia sono il motore motivazionale **dell'agentività umana**: se le persone pensano di non essere capaci di produrre un effetto su una data situazione non investono energie nell'azione.

L'autoefficacia non è, dunque una misura delle competenze possedute, ma la **credenza che la persona ha in ciò che è in grado di fare in diverse situazioni con le capacità che possiede.**

Bandura, A. (2012). *Autoefficacia. Teorie e applicazioni.* Erickson, pp.33-36.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Differenza tra autostima e autoefficacia

L'autostima sembra molto affine all'autoefficacia, ma in realtà i due concetti indicano fenomeni diversi.

L'**autostima** ha a che fare con le valutazioni di **valore personale**, mentre l'**autoefficacia** riguarda **giudizi sulle capacità** personali.

Gli individui possono considerarsi altamente efficaci in una attività dalla quale non ricavano alcuna stima di sé, o giudicarsi inefficaci in una attività senza subire una perdita del valore di sé.

- Bandura, A. (2012). *Autoefficacia. Teorie e applicazioni.* Erickson, pp.33-36.

Domande di orientamento allo studio

- Cosa si intende oggi per promozione della Qualità di Vita e quali sono i domini che la costituiscono?
- Quali sono i principi di funzionamento del modello QdV?
- Cosa caratterizza il concetto di benessere nel modello PERMA? Cosa si intende per flourishing?
- Come si è evoluto il concetto di empowerment nel lavoro sociale e qual è l'accezione post-moderna di empowerment relazionale?
- Quali sono le principali caratteristiche/differenze dei concetti di autonomia, autostima e autoefficacia?

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Bibliografia di riferimento

- Bandura, A. (2012). *Autoefficacia. Teorie e applicazioni*, Erickson.
- Brandani, W., Tramma S. (2014). *Dizionario del lavoro educativo*, Carrocci.
- Cappello, F. (2011). Seminare domande. La sperimentazione della maieutica di Danilo Dolci nelle scuole, in Educazione Democratica, 2/giugno 2011, pp.178-183.
- Carbonari, M. (2017). *Leggere la qualità di vita dell'adulto con disabilità*, Tesi di dottorato, Università di Macerata
- Dal Pra Ponticelli, M. (2007). *Dizionario di servizio sociale*, Carocci.
- Domingo, P. (2011). *Ciascuno cresce solo se sognato*. Nonviolenza, sogno e liberazione nella pedagogia di Danilo Dolci, in Educazione Democratica, 2/giugno 2011, pp.13-22.
- Folgheraiter, F. (a cura di). (2004). *Il servizio sociale postmoderno: modelli emergenti*, Erickson
- Laudadio, A. Mancuso, S. (2015). *Manuale di Psicologia positiva*, Franco Angeli.

Finalità dell'intervento dell'operatore sociale

Bibliografia di riferimento

- La Rocca, G. (2011). L'innovazione sociale nel segno della continuità con l'approccio maieutico reciproco, in Educazione Democratica, 2/giugno 2011, pp. 184-189.
- Nussbaum, M. (2002). *Giustizia e dignità sociale. Da individui a persone.* Il Mulino
- World Health Organization. (1986). Ottawa Charter for Health Promotion. Regional Office for Europe.
- Saraceno, C. (2012). Diseguaglianze che segnano destini, in Animazione Sociale, Inserto, gennaio 2012, pp. 49-60.
- Shalock, R., Verdugo, A. M. (2006). *Manuale della qualità di vita*, Vannini.
- Sen, A. K. (2000). *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia.* Mondadori.
- Tramma, S. (2018). *L'educatore imperfetto. Terza edizione*. Carocci.